Roche

从一次研修班到持续学习网络

以真实诊断难题为入口，连接专家、区域与一线病理医生，构建可持续的专业影响力。

70+
参会医生

2 × 5
天数 × 专题

90%
首选专题讲座

业务命题

从孤立学习走向持续连接

复杂病例增加、亚专科资源不均与 MDT 协作要求，让“一次性培训”难以承接真实工作场景。

01
诊断复杂度持续上升
常规阅片之外，疑难病例需要更系统的诊断框架与专家经验。

02
区域医生容易“单兵作战”
亚专科专家稀缺，学习与答疑缺少稳定、可回访的连接机制。

03
病理在 MDT 中需要更强表达
从给出结论，升级为参与临床决策和治疗路径讨论。

Roche

项目策略

把课程设计成一条学习路径

现场解决“会不会”，连接解决“遇到时找谁”。

以病例为核心、专家为节点、区域为网络，让培训从知识输入走向长期协同。



执行路径

两天活动，四个关键动作

STEP 01

精准邀约

以诊断需求和区域影响力为线索，锁定核心参与者。

32 人

STEP 02

实战教学

围绕 5 个主题，结合典型病例建立诊断思维。

2 天 × 5 题

STEP 03

数据复盘

用问卷和反馈识别内容偏好、未满足需求与升级方向。

21 份

STEP 04

病例共识

将阅片、MDT 和答疑机制延伸到会后日常工作。

长期连接

执行原则：**少讲概念，多讲病例；少做单向传播，多做可回访互动。**

现场时刻

从听课，到共同推演



专家授课与病例拆解



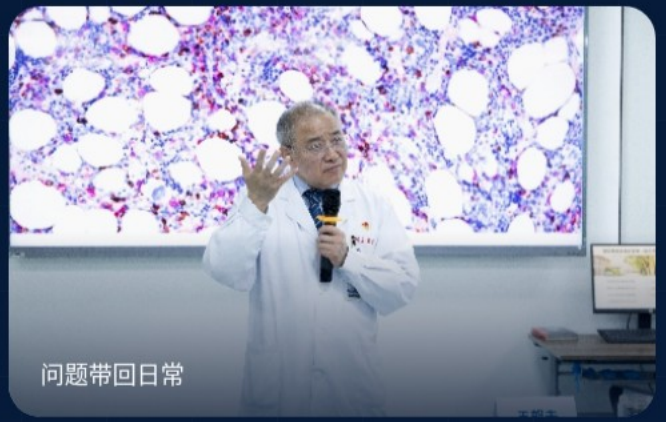
互动讨论

70+

专业连接在现场发生



区域共学



问题带回日常

量化结果

不是“办完一场会”，而是验证一条路径

70+

参与医生

32 名定向邀请，叠加 40+ 自主参会，体现主题吸引力与区域触达。

90%

最认可专题授课

结构化讲解仍是最具确定性的学习入口。

81%

希望强化阅片

需求进一步指向常规阅片和疑难诊断。

71%

首选 MDT 实践

医生期待从诊断走向临床决策协同。

14

主动感谢留言

情感反馈验证了专业体验与关系价值。

关键洞察

医生需要的不只是一场好课，而是遇到难题时仍能找到答案。

基于 21 份有效问卷及现场反馈

更深

延长病例讨论

减少泛讲，增加疑难病例的诊断推演与关键分歧。

更多

扩大真实案例池

由专家单向供给，升级为区域共建、持续积累。

更频

建立固定触点

用线上答疑和阶段复盘保持学习节奏。

更广

连接 MDT 场景

让病理观点在临床决策中被看见、被采用。

项目价值从“满意度”升级为：**能力提升 × 专业连接 × 业务影响**

Roche

下一步

构建三层学习生态

把一次成功活动复制为持续机制，让区域经验真正沉淀。

LAYER 01

持续学习网络

固定主题节奏、线上答疑与病例回访，保持专业连接。

LAYER 02

区域师资梯队

识别核心讲者与青年骨干，形成可扩展的内容供给。

LAYER 03

MDT 实践场

将病例讨论连接临床决策，放大病理专业影响。

负责人：东区–PSM–Luke

从单点活动 → 区域能力平台

08